

MÉDECINE INTERNE

Dr.KHERBA_N

MÉDECINE INTERNE

Behçet

Cellulite

Engelures

Érysipèle

Pied diabétique

Purpura rhumatoïde

Sécheresse buccale

Maladie de Behçet

● Clinique

Aphthose récidivante bipolaire buccale, génitale, articulaire, cutanée (Folliculite, érythème noueux)..

■ Forme bénigne :

Aphtes buccales +/- génitales douloureux mais sans atteinte systémique (oculaire, neurologique, vasculaire..), absence des signes infectieux ni AEG

⇒ Pas besoin d'hospitalisation

■ Forme modérée à sévère :

Aphtes très nombreux, fièvre, AEG, arthrite, signes neurologiques, digestifs, vasculaire..

⇒ Hospitalisation (médecine interne)

⚠ 3 épisodes aphtosiques pendant une année
fait suspecter la maladie de Behçet

■ Pour l'enfant cette maladie est rare, le diagnostic après l'âge de 15ans..

■ Bilan : 

■ FNS : Hyperleucocytose à PNN

■ CRP/VS : syndrome inflammatoire

✓ Traitement :

■ Pousée => Colchicine 1_2mg/j

■ Fond => CTC oral Prednisone 0.5mg/kg/j pdt 7_10j avec décroissance rapide

■ Traitement local des aphtes : bain de bouche, anesthésie locaux « Xylocaïn »

■ Crème corticoïde pour les aphtes génitales

■ Supplémentation vitaminique en B9 B12

■ Si échec => immunodépresseurs

✳ Diagnostic Positif :

Le diagnostic de la maladie de Behçet se fait de nos jours par la nouvelle classification (critères internationaux 2013). Le diagnostic est retenu si le score est égal ou supérieur à 4:

- ✓ Atteinte ophtalmologique:(2 points);
- ✓ Aphtose génitale:(2 points);
- ✓ Aphtose buccale:(2 points);
- ✓ Manifestations cutanées:(1 point);
- ✓ Manifestations neurologiques:(1 point);
- ✓ Manifestations vasculaires:(1 point);
- ✓ Test de pathergie:(1 point).



Cellulite

● Clinique :

Infection du tissu adipeux sous cutané,
Strepto++

Douleur + chaleur + œdème + érythème.

➡ Echographie des parties molles pour
éliminer une collection abcédée

■ Bilan infectieux : 

■ FNS

■ CRP

Contrôle CRP/48h

⊖ Les AINS sont CI

✓ Traitement : Hospitalisation

Immobilisation si cellulite de membre super ou infer.

1 Cefazoline 1g 3/j pdt 10j

Ou Augmentin cp ou st 1g 3/j pdt 7_10j

2 Flagyl 500mg 3/j en perf

3 Lovenox 0.4Ui

■ Au niveau de visage :

1 Amoxicilline 50mg/kg/j

2 Flagyl 30mg/kg/j

3 Paracétamol

4 Bain de bouche

■ Si aggravation des signes après 48h : ATB en IV

Avis ORL

■ Si terrain :

Pyostacine cp 500mg 2cp 2/j

Ou Fucidine cp 250mg 2cp 3/j



Engelures

● Clinique :

Blessure par le froid qui se traduit par des zones cutanées rouges, démangeaisons et tendres..

✓ Traitement :

- Massage par les huiles essentielles
- Bain à l'eau tiède 15_30min

1 Akilenjure crème 1app 4/j

Ou Dexeryl pmd 1app 2/j

Ou Vaseline 1app 2_3/j

2 Allertine ou Loratidine cp 10mg 1cp/j le soir



Érysipèle

Clinique :

- Dermohypodermite bactérienne aigue non nécrosante
- Zone inflammatoire rouge douloureuse unilatérale de la peau surtout le membre inférieur +++ d'origine strepto+++
- Plaque érythémateuse à bordure nets, chaud, fièvre, frissons.
- Penser toujours à une TVP=> signes de Homonas/palper mollet.
- Rechercher la porte d'entrée : Intertrigo

Critères d'hospitalisation :

- Évolution défavorable après 72h
- Signes généraux importants
- Fébrile ou présence des signes de nécrose

- Terrain : ID, diabétique..
- Si non traitement Ambulatoire

✓ Traitement :

- Repos avec surélévation du membre
- Augmentin 1g 3/j pdt 15j
- Doliprane cp 1g 1cp 3/j

■ Traitement de la porte d'entrée souvent :
Intertrigo

Mycoster crème 1app 2/j pdt 21j

Ou Pevaryl spray 1app 2/j

■ Si allergie : aux Pénicillines

Pyostacine cp 500mg 2cp 3/j pdt 15j

Si pas disponible => Rovamycine

⊖ Les AINS sont CI

■ Si: Hospitalisation

■ Peni G 5Mui (3_6Mui) dans 250cc de SG5% en IVL 1/j pdt 2j

■ Puis relais par Traitement de sortie :

Orapen 1Mui 1cp 2/j pdt 10j

Ou Cefacet 1g inj IVD + Flagyl 500mg inj IVL

Ou Cefacet 1g inj IVD + Genta 80mg inj IVL

+ Lovenox à dose préventive 0.4/24h

Ou Traitement de sortie : pdt 10j

Augmentin St 1g 3/j

Flagyl 500mg 2/j

Ou Pyostacine 1g 2/j

Flagyl 500mg 2/j

Ou Lexinal cp 1g 1cp 2/j pdt 10 à 12j

Pyostacine cp 500mg 1cp 2/j pdt 10j

Doliprane

- Bilan 
- Glycémie
- Echodoppler



Pied diabétique

✓ Traitement :

- Sabot pour les pied diabétique
- S'éloigner de toute source de l'eau

1 Pyostacine cp 500mg 2cp 2_3/j si atteinte osseuse

Ou Lexin cp 1g 1cp 3/j pdt 7j

Ou Cefacet 1g 2/j si présence du pus

Ou Augmentin 3g/j

Ou Claforan 1g 4/j

Ou Ciprolon 400mg 2/j

2 Flagyl cp 500mg 1cp 3/j

Ou Fucidine pmd 1app 3/j

Après lavage au SSI

+/_ Lovenox 0.4

- Bilan complet  :
- FNS
- CRP/VS
- Urée/Créat
- Hémostase : TP/TCK/INR
- Ionogramme/Ca
- Gly à jeûne / HbA1C / CU

- Rx de pied=> Ostéite
- Echodoppler des MI bilatérale
- Échographie des parties molles
- Soins locaux/j SSI Flammazine + Tulle gras
- Proscrire le Dakin et Betadine
- Contrôle en 48_72h
-  Avis Chirurgie

Purpura rhumatoïde

- Vascularite à IgA, Enfant +++
 - Atteinte des capillaires sanguins en fait une maladie systémique entraînant des anomalies de la peau, des reins, des articulations et du système digestif.
 - Rechercher des complications rénales et digestives
 - Examen ORL
- Prise de TA
- Bilan standard : 
- FNS (taux de paquettes normal)
- Urée/Créat
- CRP/VS
- Bilan d'hémostase : TP/TCA (normal)
- CU : atteinte rénale

- Protéinurie des 24h
- Ionogramme sanguin
- Électrophorèse des protéines
- Complément c3

✓ CAT :

- Repos
- Alimentation liquide ou semi liquide
- Si douleur abdominale=> Antispasmodique
- CTC : Solumedrol



Sécheresse buccale Xérostomie

- Causes :
- Maladie de système
- Syndrome sec Gougerot Sjögren secondaire au Polyarthrite rhumatoïde ou LES
- Médicaments : Atropine, Antidépresseurs, Radiothérapie
- Bilan : immunologique

 Traitement :

Sulfarem 25mg